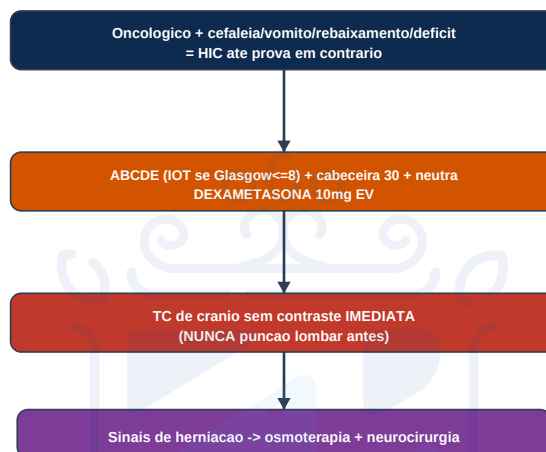


HIC DA MALIGNIDADE — DEXAMETASONA + IMAGEM

FLUXOGRAMA — EMERGÊNCIA NEUROLÓGICA

HIC — CABECEIRA, DEXAMETASONA, TC, TRANSFERIR



DEFINIÇÃO E CAUSAS

O QUE É

- Emergência neurológica: aumento crítico da pressão intracraniana em paciente oncológico
- Causas: METÁSTASES cerebrais, tumores primários do SNC, edema vasogênico tumoral, hidrocefalia obstrutiva, hemorragia tumoral
- Consequências: redução da perfusão cerebral, herniação, coma e morte se não tratada
- Em oncológico, REBAIXAMENTO ou déficit focal AGUDO = HIC até prova em contrário

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

DO INICIAL AO TARDIO

- Iniciais: cefaleia progressiva (PIOR pela manhã), náuseas/vômitos em jato, visão turva/diplopia, sonolência
- Gravidade: rebaixamento do nível de consciência, déficit focal, convulsões, anisocoria, postura de descerebração/decorticação
- Tardio (herniação iminente): TRIÁDE DE CUSHING (bradicardia + hipertensão + irregularidade respiratória)
- Não atrasar: tempo perdido = risco de herniação
- Suspeita -> elevar a cabeceira, dexametasona e providenciar imagem/transferência

AValiação e Exames

ABCDE + IMAGEM

- ABCDE imediato: via aérea (IOT se Glasgow ≤ 8), O₂, monitor, acesso calibroso
- Neuro rápido: Glasgow, pupilas, déficits focais, sinais de lateralização
- TC de crânio SEM contraste IMEDIATA: massa, edema, desvio de linha média, hidrocefalia, hemorragia
- NUNCA realizar punção lombar antes da imagem (risco de herniação)
- Laboratório geral: hemograma, PCR, eletrólitos (Na, K, Ca), função renal

TRATAMENTO NO PS

Rx POSIÇÃO + DEXAMETASONA + OSMOTERAPIA

Cabeceira elevada a 30 graus, cabeça em posição NEUTRA (sem rotação)

DEXAMETASONA (pilar do edema tumoral): 10 mg EV imediato + 4 mg EV 6/6h (efeito em horas)

Osmoterapia (se HIC grave): Manitol 20% 0,5-1 g/kg EV em 15-20 min (repetir 6-8/8h; monitorar osmolaridade/função renal)

OU Salina hipertônica 3% 250 mL EV em 20 min (alternativa se hipotensão/IR)

Convulsão: Diazepam 10 mg EV ou Midazolam 5 mg; profilaxia (lesão cortical/crise prévia): Levetiracetam 500-1000 mg 12/12h

Suporte: SatO2 > 94%, PaCO2 35-40 (se ventilado), evitar hipotensão, glicemia 140-180, analgesia + ondansetrona

MENSAGEM-CHAVE / ENCAMINHAMENTO

TODOS DEVEM SER ENCAMINHADOS

- Suspeitou de HIC em paciente oncológico? Eleve a cabeceira, faça DEXAMETASONA e providencie IMAGEM + transferência imediata
- Todo paciente com HIC suspeita/confirmada deve ser internado e avaliado pela neurocirurgia
- Osmoterapia (manitol/salina hipertônica) é ponte na herniação iminente
- Corticoide trata o edema VASOGÊNICO (tumoral) — não o edema citotóxico do AVC
- Tempo perdido = risco de herniação cerebral

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente oncológico (___) com suspeita/confirmação de HIC; alteração neurológica: ___; Glasgow ___.
- TC de crânio: ___ (massa/edema/desvio de linha média/hidrocefalia/hemorragia).
- Condutas: cabeceira 30, DEXAMETASONA, osmoterapia ___, profilaxia/tratamento de convulsão, IOT se RNC.
- Solicito internação + neurocirurgia (vigilância neurológica) — transferência imediata.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente oncológico com cefaleia matinal, vômitos em jato e sonolência. Qual a conduta inicial além da imagem?

- A) Punção lombar imediata
- B) Elevar a cabeceira a 30 graus e administrar dexametasona, providenciando TC de crânio
- C) Apenas analgésico e alta
- D) Iniciar anticoagulação
- E) Hidratação vigorosa para diurese alta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o pilar do tratamento do edema vasogênico tumoral na HIC da malignidade?

- A) Manitol isolado
- B) Dexametasona (corticoide)
- C) Furosemida
- D) Solução salina 0,9%
- E) Antibiótico

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que NÃO se deve realizar punção lombar antes da TC na suspeita de HIC?

- A) Por desconforto do paciente
- B) Pelo risco de herniação cerebral
- C) Porque a punção é sempre normal
- D) Porque atrasa o antibiótico
- E) Porque não há líquido

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual achado caracteriza a tríade de Cushing (sinal tardio de herniação iminente)?

- A) Taquicardia, hipotensão e taquipneia
- B) Bradicardia, hipertensão e irregularidade respiratória
- C) Febre, sudorese e tremor
- D) Hipoglicemia, palidez e síncope
- E) Anisocoria isolada

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual conduta é indicada na HIC grave com sinais de herniação iminente?

- A) Apenas observação
- B) Osmoterapia (manitol 20% ou salina hipertônica 3%) e acionamento da neurocirurgia
- C) Reduzir a cabeceira
- D) Suspender o oxigênio
- E) Hiperventilação prolongada de rotina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Em oncológico com sinais de HIC, eleva-se a cabeceira a 30 graus (cabeça neutra) e administra-se dexametasona (reduz o edema vasogênico em horas), providenciando TC de crânio imediata. Punção lombar é contraindicada antes da imagem.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A dexametasona é o pilar do tratamento do edema vasogênico tumoral (10 mg EV + 4 mg 6/6h). A osmoterapia (manitol/salina hipertônica) entra na HIC grave/herniação como ponte.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A punção lombar antes da imagem em HIC com efeito de massa pode precipitar herniação cerebral pela redução abrupta da pressão líquórica caudal. Por isso, sempre TC primeiro.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A tríade de Cushing — bradicardia + hipertensão + respiração irregular — é sinal TARDIO de herniação iminente, refletindo a tentativa de manter a perfusão cerebral.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na HIC grave com herniação iminente, usa-se osmoterapia (manitol 20% 0,5-1 g/kg ou salina hipertônica 3%) como medida de ponte, com acionamento imediato da neurocirurgia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico